Azienda Ospedaliera Valdarno Nuovo
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare
Laboratorio di Genetica Molecolare Cardiovascolare
Responsabile: Dott.ssa Ilaria Guarducci

Viale dei Mandorli 40
50139 Firenze
Tel. 055 7946021

REFERTO DI TEST GENETICO

Pannello NGS per cardiomiopatie ereditarie (62 geni)

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Lorenzo Bacci**	Codice fiscale:	**BCCLNZ79C14E625I**
Nato il:	**14/03/1979**	Residenza:	**Via Pistoiese 211, Prato**
Medico richiedente:	**Dott. Niccolò Pratesi**		

N. referto: 25GMC-0187
Prelievo: 12.02.25
Emissione: 3 aprile 2025
Materiale: Sangue periferico (EDTA)

Codice DNA: DNA-25-00412

INDICAZIONE AL TEST

Il pz., di 45 aa., è seguito presso l'u.o. Cardiologia per cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva (spessore massimo del setto interventricolare 23 mm all'ecocardiogramma). Anamnesi familiare positiva per morte cardiaca improvvisa del padre all'età di 52 anni. Il sig. Bacci è portatore di defibrillatore impiantabile (ICD) in prevenzione primaria.

METODICA

Arricchimento mediante cattura con sonde (Twist Custom Panel) e sequenziamento paired-end 2x150 bp su piattaforma Illumina NextSeq 550. Allineamento sul genoma di riferimento GRCh38; chiamata delle varianti con pipeline interna validata. Copertura media 412x, regioni con copertura almeno 20x pari al 99,3%. Le varianti di interesse clinico sono state confermate con sequenziamento Sanger su secondo prelievo. Classificazione secondo le linee guida ACMG/AMP 2015 e successive raccomandazioni ClinGen.

RISULTATO

Gene	Trascritto	Variante HGVS c.	Variante HGVS p.	Zigosità	Classe ACMG
MYBPC3	NM_000256.3	c.1504C>T	p.(Arg502Trp)	Eterozigote	Patogenetica (classe 5)
MYH7	NM_000257.4	c.4472C>T	p.(Ser1491Leu)	Eterozigote	Significato incerto (classe 3)

Non sono state rilevate altre varianti di classe 3, 4 o 5 nei geni del pannello.

INTERPRETAZIONE

La variante MYBPC3 c.1504C>T in eterozigosi è ampiamente descritta in soggetti affetti da cardiomiopatia ipertrofica ed è classificata come patogenetica: il risultato fornisce una **spiegazione molecolare** del quadro clinico del sig. L. Bacci. La variante del gene MYH7 è al momento di significato incerto e non deve essere utilizzata per decisioni cliniche né per lo screening dei familiari; potrà essere rivalutata alla luce di nuove evidenze.

CONSULENZA GENETICA E SCREENING FAMILIARE

La trasmissione è autosomica dominante: ciascun figlio del paziente ha una probabilità del 50% di avere ereditato la variante. Si raccomanda il test a cascata della sola variante MYBPC3 nei familiari di primo grado, previa consulenza genetica. Durante il colloquio pre-test il paziente ha indicato i seguenti familiari, che ha autorizzato a contattare per il tramite della moglie, sig.ra Serena Mazzei.

Familiare	Parentela	Data di nascita	Stato clinico	Test proposto
Riccardo Bacci	Fratello	07/06/1982	Asintomatico, ECG non noto	Test mirato + ecocardiogramma
Tommaso Bacci	Figlio	21/09/2009	Asintomatico	Test mirato (minore, con consenso dei genitori)
Mirella Cecconi	Madre	30/11/1954	Ipertensione arteriosa	Test mirato

Il prossimo colloquio di consulenza è fissato per il 15-05-2025 presso l'Ambulatorio di Genetica Clinica. Una copia del referto viene trasmessa al Dott. Niccolò Pratesi per l'aggiornamento della stratificazione del rischio aritmico.

Limiti del test: la metodica non rileva in modo affidabile riarrangiamenti strutturali complessi, varianti in regioni introniche profonde e mosaicismi di basso livello. Un risultato negativo nei familiari esclude la variante familiare ma non altre cause di cardiomiopatia.

Il Biologo responsabile del laboratorio
Dott.ssa Ilaria Guarducci

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firenze, 03/04/2025

Il Medico Genetista

Dott. Fabrizio Nesi

AO VALDARNO NUOVO
GENETICA MEDICA
Dott. Fabrizio Nesi
Ord. Medici FI n. FI-13874

Consulenza genetica pre e post-test